

PYROPOÏKILOCYTOSE TRANSITOIRE DU NOUVEAU-NE :
UNE PRESENTATION NEONATALE DE L'ELLIPTOCYTOSE HEREDITAIRE



A. MILOUDI ; H. S. SAHLI ; R. MOKRANI ; S. AIT YAHIA ; K. KHERMOUCHE ; D. HANCHI ; L. LAMMARI ;
S. BENSABA ; I. FRIGAA.
- CHTS CHU Mustapha Alger –
- E-mail: miloudi.amel@gmail.com

INTRODUCTION

La pyropoïkilocytose transitoire du nouveau-né (PTN) est une forme néonatale rare de l'elliptocytose héréditaire (EH), caractérisée par une anémie hémolytique sévère avec fragmentation marquée des globules rouges. Ce phénotype transitoire évolue spontanément vers une EH classique au cours des premiers mois de vie, parallèlement au remplacement physiologique de l'HbF par l'HbA et à la restauration progressive de la stabilité des interactions horizontales du cytosquelette érythrocytaire. ⁽¹⁾

L'objectif de notre travail est de rapporter un cas de PTN diagnostiqué au CHTS CHU Mustapha Pacha et d'analyser ses particularités clinico-biologiques.

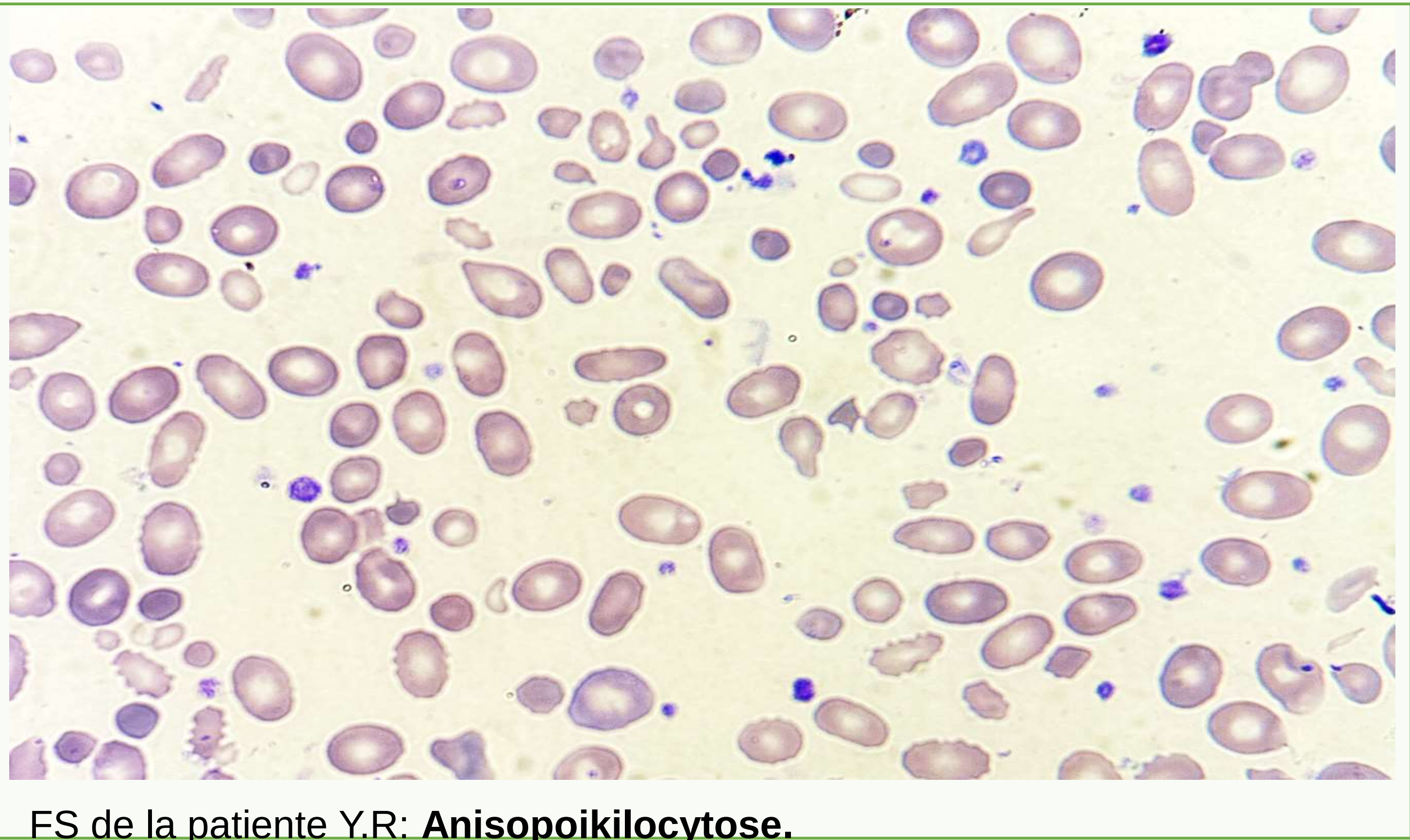
PATIENTS ET METHODES

Patient Y.R., âgée de 9 jours, explorée pour un ictère néonatal associé à une anémie. Le bilan comprenait un interrogatoire, une enquête familiale, une NFS avec réticulocytes (Sysmex XN-3100), un frottis sanguin (CellaVision) et un test direct à l'antiglobuline (TDA). Le test de fragilité osmotique n'a pas été réalisé en raison d'une transfusion urgente.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

	Âge	GB (10*3/uL)	Hb (g/dL)	PLT (10*3/uL)	RET (10 ³ ele/mm ³)	TDA
Y.R	09 jours	12.35	10.80	562.00	62.10	Négatif

- Anémie avec ictère néonatal.
- Le PT non fait suite une la transfusion en urgence de la patiente.
- FS de Y.R en pré-transfusionnel: présence d'une **anisopoikilocytose majeure** avec nombreux elliptocytes, micro-elliptocytes, sphérocytes, microsphérocytes, ovalocytes, schizocytes et fragments de GR, ce qui a déclenché de nombreuses **alarmes de l'analyseur**. On note une apparition d'une double population dans l'**histogramme** de distribution des volumes érythrocytaires avec **chevauchement** entre les populations érythrocytaires et plaquettaires ayant donné une **pseudo-thrombocytose** sur l'NFS.
- La **pyropoïkilocytose transitoire du nouveau-né** se manifeste dès la naissance par une anémie hémolytique sévère accompagnée d'une importante fragmentation des GR, elle est souvent transitoire et s'améliore progressivement pour aboutir à un tableau d'EH asymtptomatique ou modéré. Cette transition pourrait s'expliquer par des changements dans la composition de l'hémoglobine (passage de l'HbF à l'HbA) et ses interactions avec le cytosquelette. ⁽²⁾ ⁽³⁾
- L'enquête familiale est revenue positive.
- Elliptocytose héréditaire (transmise par la mère).



FS de la patiente Y.R: **Anisopoikilocytose**.



FS de la mère de Y.R: **Elliptocytose**.

L'EH est une affection souvent sous-diagnostiquée, notamment dans les formes asymptomatiques ou modérées. Le diagnostic repose sur :

- Le **frottis sanguin**, qui met en évidence une proportion variable d'elliptocytes, généralement plus de 15%.⁽⁴⁾
- Le **test de fragilité osmotique**, parfois altéré dans les formes sévères. Sa normalité ne permet donc pas d'exclure une EH.⁽⁵⁾
- Le test de **EMA** est un test performant, cependant, il est peu contributif dans les formes classiques d'EH car il est normal.⁽⁶⁾
- L'**exclusion** des autres causes d'hémolyse, notamment les anémies hémolytiques auto-immunes et les déficits enzymatiques.⁽⁶⁾



- L'**ektacytométrie** est la **technique de référence** permettant de confirmer le diagnostic d'EH/PPH par des profils caractéristiques.⁽⁷⁾
- L'**étude génétique**, qui permet d'identifier les mutations impliquées (SPTA1, SPTB, EPB41) en cas de diagnostic incertain.⁽³⁾
- Le **traitement** est généralement conservateur, reposant sur une surveillance régulière et une supplémentation en acide folique. Dans les formes sévères, une splénectomie peut être envisagée, permettant de réduire l'hémolyse.⁽³⁾

CONCLUSION

La pyropoïkilocytose transitoire du nouveau-né constitue une présentation néonatale rare de l'EH. Devant une anémie hémolytique avec ictère néonatal, l'analyse experte du frottis sanguin, associée à l'enquête familiale, permet d'orienter précocement le diagnostic, d'éviter des explorations inutiles et d'optimiser la prise en charge.

RÉFÉRENCES

1- Baiya M, Elkhannouri I, Mhirig I, Sayagh S (2022) Hereditary elliptocytosis discovered during work-up for infective endocarditis: About a case. Arch Hematol Case Rep Rev 7(1): 013-014.
2- Bock I, Perrin J, Braun F, Garçon L, Lesesve J. Une observation de pyropoikilocytose héréditaire de découverte tardive et d'expression clinique modérée. Ann. Biol. Clin. (Paris). 2012 Jul 1;70(4):483-8.
3- L. Garçon, Diagnostic biologique des maladies constitutionnelles de la membrane érythrocytaire, Archives de Pédiatrie, Volume 16, Issue 6, 2009, Pages 553-555, ISSN 0929-693X.
4- aissam elmaataoui. "Elliptocytose Héréditaire : à Propos d'Une Observation." Revue Francophone Des Laboratoires, 2010.
5- Perrin J, Marchand-Arvier M, Latger-Cannard V, Vigneron C, Lecompte T. Une résistance globale osmotique normale n'exclut pas une membranopathie érythrocytaire ! À propos d'un cas d'elliptocytose héréditaire. Ann. Biol. Clin. (Paris). 2006 Sep 1;64(5):491-5.
6- Véronique PICARD, DOSSIER : Maladies constitutionnelles du globule rouge, Diagnostic biologique des pathologies, constitutionnelles de la membrane érythrocytaire, Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2014 // Volume 04 // Numéro 01.
7- Kalfa TA. Diagnosis and clinical management of red cell membrane disorders. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2021 Dec 10;2021(1):331-340. doi: 10.1182/hematology.2021000265. PMID: 34889366; PMCID: PMC8791164.